Samedi 03: Cancer du Colon

Cas Clinique : Cancer Colique

Énoncé initial

Patient âgé de 65 ans, sans antécédents personnels ou familiaux particuliers, se présente en consultation pour des douleurs abdominales évoluant depuis 4 mois, avec une notion de constipation d'apparition récente et d'un amaigrissement chiffré à 6 kg en 2 mois.

Examen clinique :

- Ne retrouve rien de particulier en dehors d'une douleur à la palpation profonde du flanc gauche et de l'hypogastre.
- L'examen de la marge anale et le toucher rectal objectivent un sphincter normotonique, pas de masse palpable, doigtiers souillés de sang.

Question 1

Devant cette symptomatologie, quels sont les diagnostics à évoquer devant ce tableau clinique ?

- a) Diverticulose sigmoïdienne
- b) MICI
- c) Tuberculose intestinale
- d) Cancer colique
- **e) Toutes ces réponses sont justes** *(Bonne réponse)*

Question 2

Devant ces données cliniques et anamnestiques, une forte probabilité de cancer est évoquée, dans quelle classe de sujet à risque classez-vous ce patient ?

- **Réponse : Risque intermédiaire** *(Bonne réponse)*

Question 3

Devant ce tableau clinique, quel examen demanderiez-vous ? *(noté radiologique dans le texte)*

- a) Échographie abdominale
- b) Scanner abdominal avec injection de produit de contraste
- **c) Colonoscopie totale** *(Bonne réponse)*
- d) Rectoscopie
- e) IRM abdominale

Évolution 1

Une colonoscopie est réalisée et retrouve un processus circonférentiel ulcéro-bourgeonnant du côlon gauche près de l'angle colique non sténosant avec la présence de 2 polypes infracentimétriques (l'un au niveau de l'angle colique gauche et l'autre au niveau du côlon transverse). Des biopsies ont été réalisées dont l'examen anatomopathologique est en faveur d'un adénome tubulo-villeux avec dysplasie de bas grade.

Question 4

Quel autre examen demanderiez-vous afin de renforcer votre hypothèse diagnostique ?

- a) Les marqueurs tumoraux (ACE)
- b) Scanner thoraco-abdomino-pelvien
- c) IRM abdominale
- d) PET scan
- **e) Toutes ces réponses sont fausses** *(Bonne réponse)*

> *Note explicative (encadré du document) : Uniquement une colonoscopie avec biopsies.*

Évolution 2

Il s'agit d'un patient âgé de 62 ans sans antécédents particuliers avec un adénocarcinome bien différencié du côlon gauche classé cT3N+M0, présentant par ailleurs deux polypes non réséqués dont l'étude anatomopathologique retrouve une dysplasie de bas grade.

Question 5

Quel sera votre projet thérapeutique ?

- a) Chirurgie carcinologique d'emblée
- b) Résection endoscopique des polypes suivie d'une chirurgie carcinologique seule
- c) Radiothérapie néoadjuvante
- d) Chimiothérapie néoadjuvante
- **e) Résection endoscopique des polypes suivie d'une chirurgie carcinologique avec une éventuelle chimiothérapie adjuvante** *(Bonne réponse)*

Question 6

Sachant qu'une résection endoscopique des deux polypes a été faite avec succès montrant une dysplasie de bas grade, quel geste chirurgical préconisez-vous ?

- a) Une hémicolectomie gauche avec un curage mésentérique inférieur
- b) Une colectomie subtotale avec curage mésentérique inférieur et supérieur
- c) Une colostomie de proche amont
- **d) Une résection segmentaire gauche avec curage mésentérique inférieur** *(Bonne réponse)*
- e) Coloprotectomie avec curage mésentérique inférieur

Notes techniques associées :

- La marge de sécurité est de 5 cm, parfois 10 cm si infiltrant (marge longitudinale).
- Curage ganglionnaire : minimum de 12 ganglions (si moins, c'est un curage insuffisant).
- On squelettise l'artère (ramener tout le tissu cellulolymphatique).

Question 7

Une résection segmentaire a été réalisée avec curage mésentérique inférieur, l'étude anatomopathologique est revenue en faveur d'un adénocarcinome colique bien différencié classé pT3N2M0. Quelle sera votre attitude ?

- a) Surveillance seule
- b) 12 séances de chimiothérapie adjuvante
- c) Radiothérapie adjuvante
- d) Immunothérapie

- **e) Chimiothérapie adjuvante et surveillance** *(Bonne réponse)*